

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Ustekinumab 45mg, 90mg (스텔라라프리필드주45mg, 90mg, (주)한국얀센)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정 중 ustekinumab 45mg, 90mg

☐ **효능 효과 :**

- 광선요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도-중증의 판상 건선질환을 가지고 있는 18세 이상의 성인

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2011년 제15차 약제급여평가위원회 : 2011년 12월 22일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2011년 10월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2011년 제15차 약제급여평가위원회 평가결과 : 조건부 비급여

- 신청품은 “광선요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도-중증의 판상 건선질환을 가지고 있는 18세 이상의 성인”에 허가받은 약제로, 투여 횟수 감소에 의한 편의성 개선이 인정되고 etanercept대비 효과 개선이 있으나, 대체약제 대비 연간 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가(■■■원) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “광선요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도-중증의 판상 건선질환을 가지고 있는 18세 이상의 성인”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 etanercept, adalimumab, infliximab이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 전신 치료요법 또는 광선요법에 반응하지 않거나 금기인 중등도-중증의 판상건선치료에 TNF- α 억제제(etanercept, adalimumab, infliximab), ustekinumab, pathogenic T-cell 제제(alefacept)가 추천되고 있으며,¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 신청품은 interleukin 12(IL-12)와 intereukin 23(IL-23)의 p40 subunit에 결합하여 건선의 면역반응을 억제하는 약제임⁵⁾.
- 중등도-중증의 판상건선 환자 대상으로 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 활성약 대조 3상 임상시험에서 신청품을 0주, 4주에 투여(45mg: N=209, 90mg: N=347)하고 Etanercept 50mg(N=347)을 12주간 주 2회 투여한 후 12주째 유효성 안전성을 평가한 결과, 12주째 PASI 75⁶⁾반응은 신청품군이 Etanercept 50mg군 보다 유의하게 높음 (신청품 45mg 67.5%(p=0.012), 신청품 90mg군 73.8%(p<0.001), etanercept 50mg 56.8%)⁷⁾.
- 중등도-중증의 판상건선 환자 대상으로 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 3상 임상시험에서(PHOENIX 1: 45mg N=255, 90mg N=256, Placebo N=255/ PHOENIX2: 45mg N=409, 90mg N=411, Placebo N=410) 신청품 및 위약을 0주, 4주에 투여하여 12

주제 PASI 75반응은 신청품군에 유의하게 높음(Phoenix 1: 신청품 45mg 67.1%, 신청품 90mg 67.1%, 위약 3.1% / Phoenix 2: 신청품 45mg 66.7%, 신청품 90mg 75.7%, 위약 3.7%)⁸⁾⁹⁾.

- 중등도-중증의 건선치료에 사용하는 생물학적 제제(adalimumab, efalizumab, etanercept, infliximab, ustekinumab)에 대한 20편 RCT의 메타분석 결과, 12주째의 PASI 75(체중 보정하지 않음)는 infliximab이 가장 높고, 그 다음으로 ustekinumab 90mg, 45mg, adalimumab, etanercept, efalizumab 순임[PASI 75 - Infliximab: 80%(95%CI, 70~87%), ustekinumab 90mg: 74%(95%CI, 68~80), ustekinumab 45mg: 69%(95%CI, 62~75), adalimumab: 58%(95%CI, 49~68), etanercept 50mg: 52%(95%CI, 45~59), etanercept 25mg: 39%(95%CI, 30~48), Placebo: 4%(95%CI, 3~4)]¹⁰⁾.
- 장기간(적어도 48주 이상 또는 이에 상당하는 기간을 의미함) 생물학적 제제의 사용에 있어 효과와 안전성을 비교하기 위해, FDA 허가 받은 약제(alefacept, efalizumab, etanercept, infliximab, adalimumab)의 data를 PASI 75 반응으로 분석한 결과¹¹⁾, ustekinumab의 76주까지 효과는 28주 이후에 지속적으로 유지되었으며, adalimumab의 장기효과는 Open label extension에서 52주까지 지속적으로 높게 유지됨을 보여줌. Infliximab은 24주째 효과가 82%로 가장 높았으나 투여함에 따라 효과가 떨어져 50주째 약 61%임. 본 분석의 생물학적 제제의 장기효과는 부분적으로만 알 수 있으며, 이미 개발된 건선치료 제제에 대한 장기효과 연구가 필요함.
- 신청품은 MTX또는 cyclosporin을 3개월 이상 투여하였음에도 반응이 없거나 부작용으로 치료를 지속할 수 없는 경우에 급여의 필요성이 있음¹²⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “광선요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도-중증의 판상건선의 치료”에 허가받은 약제로 MTX 또는 Cyclosporin을 3개월 이상 투여하였음에도 반응이 없거나 부작용으로 치료를 지속할 수 없는 경우에 급여되는¹³⁾ etanercept, adalimumab, infliximab을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간 소요비용(60Kg 기준, 유지용량 반영)은 []원으로 대체약제의 연간 소요비용(60Kg 기준, 유지용량 반영) []원 보다 고가임.
 - 대체약제 가중 평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 []원/45mg관임¹⁴⁾¹⁵⁾.
- 신청품 연간 소요비용(60Kg 기준, 초기용량 반영)은 []원으로 대체약제의 연간 소요비용(60Kg 기준, 초기용량 반영) []원 보다 고가임.
- 신청품은 12주 1회 투여로 대체약제 대비 투여횟수 감소에 의한 편의성 개선이 인정되고 etanercept대비 효과가 개선되었으므로 경제성 평가 대상에 해당하며 etanercept와의 비용-효용분석을 제출하였으나, []로 비용효과성이 불분명함.

○ 재정 영향¹⁶⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 2011년 상반기 대상 환자수¹⁷⁾는 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상 사용량¹⁸⁾ 기준으로 절대재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원이며, 대체약제 대체로 인한 재정소요금액²⁰⁾은 약제비만 고려시 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원 증가될 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상 사용량 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국에 등재됨²²⁾.

Reference

- 1) Habif's Clinical Dermatology, 5th ed.
- 2) CECIL, 24th ed. Chapter 35 Biologic agents.
- 3) 2010 AAD(American Academy of Dermatology). Guideline of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis-section6. Guidelines of care for the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis : Case-based presentations and evidence-based conclusions
- 4) European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2009.10.
- 5) Habif's Clinical Dermatology, 5th ed.
- 6) PASI : psoriasis area and severity index, PASI 75 : PASI improvement of at least 75% relative to baseline.
- 7) Griffiths CEM et al, Comparison of Ustekinumab and Etanercept for moderate to severe psoriasis, NEJM 2010;362:118-128
- 8) Leonardi CL et al. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 76-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 1). The Lancet 2008; 371: 1665-1674
- 9) Papp KA et al. Efficacy and safety of ustekinumab, a human interleukin-12/23 monoclonal antibody, in patients with psoriasis: 52-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PHOENIX 2). The Lancet 2008; 371: 1675-1684.
- 10) K.Reich et al, Efficacy of biologics in the treatment of moderate to severe psoriasis: A network meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Dermatol. 2011 Sep 12. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10583.x. [Epub ahead of print]
- 11) Alwawi et al. Long term efficacy of biologics in the treatment of psoriasis : what do we really know? Dermatologic therapy Vol 22,2009,431-440.
- 12) ■■■■■
- 13) 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항[약제]-etanercept주사제(엔브렐주사), Infliximab제제(품명: 레미케이드주), Adalimumab주사제(품명: 휴미라주)
- 14) ■■■■■
- 15) 신청품 45mg을 기준으로 대체약제 가중평균가를 산출하고, 90mg은 약제급여평가위원회 세부평가기준에 따라 산정기준 1-(나)를 적용함. ■■■■■

- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) EDI 청구환자수 : L400 판상건선상병으로 etanercept, adalimumab, infliximab 약제를 청구한 18세 이상 환자
- 18) 1차년도 : 스텔라라프리필드주45mg-■■■■■관, 스텔라라프리필드주90mg-■■■■■관
 2차년도 : 스텔라라프리필드주45mg-■■■■■관, 스텔라라프리필드주90mg-■■■■■관
 3차년도 : 스텔라라프리필드주45mg-■■■■■관, 스텔라라프리필드주90mg-■■■■■관
- 19) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 x 신청약가
- 20) 재정 증감액= 신청품의 연간 투약비용-대체약제의 연간 투약비용
- 신청품 연간 투약비용 = ■■■■■
- 대체약제의 연간 투약비용= ■■■■■
- 환자수(제약사 제출자료에 의함)
- 1차년도: 신환자수 ■■■■■명, 구환자수 ■■■■■명
- 2차년도: 신환자수 ■■■■■명, 구환자수 ■■■■■명
- 3차년도: 신환자수 ■■■■■명, 구환자수 ■■■■■명
- ※ ■■■■■
- 21) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 x 대체약제의 가중평균가
- 22) 제약사에서 일본약가를 제출하였으나 2011 보험 약가집에 미수재됨.